一页流程 | 角膜内皮移植术

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2024

1 是否内皮失代偿且基质相对正常?

是 → 排禁忌；视轴瘢痕 / 活动炎症 / 正常内皮等 → 不进入本常规路径。

2024 刊 p114 / PDF2

2 控炎控压与解剖修复

炎症控制≥ 3 个月、青光眼控压；虹膜隔 / 前粘连等需处理后评估。

2024 刊 p114–116 / PDF2–4

3 术式选择

眼条件好 → 倾向 DMEK ； 复杂前节、后囊 / 阀 / 儿童等 → 倾向 DSEK 。

2024 刊 p115 / PDF3

4 供体、方向与固定

内皮密度≥ 2 500 个 /mm^2 、直径 7.75~8.00 mm ； 辨方向、非接触、周边虹膜切除及合适气体量。

2024 刊 p115–116 / PDF3–4

5 早期眼压和脱离?

2~6 h 密切眼压，阻滞必要释气； OCT 见大范围脱离：DSEK 脱离 >1/3 、 DMEK 脱离 >1/4 → 再注气。

2024 刊 p117 / PDF5

6 观察、再注气与长期管理

<1/4 暂观；扩大 / 水肿不退再注气。中间阈值未明确； 2 周不用非接触测压，透明后内皮计数。

2024 刊 p114 、 117 / PDF2 、 5

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。